

El monotropismo y su telaraña de comorbilidad: enlaces directos e indirectos a condiciones conductuales, psiquiátricas y neurodelarrollo

Un brief de investigación citado.

Resumen ejecutivo

El **monotropismo** (Murray, Lawson & Lesser, 2005) es una teoría de la atención autista que enmarca el autismo como una diferencia en la *asignación de recursos*: una mente monotrópica concentra recursos de procesamiento en un pequeño número de «túneles de atención» altamente activados, dejando menos recursos para los canales periféricos. Una medida de autoinforme de 2023 — el **Monotropism Questionnaire (MQ)** — proporciona la primera validación empírica, mostrando que las personas autistas y con TDAH puntúan significativamente más alto que los controles no autistas/no TDAH [1][2][3]. Un modelo cercano revisado por pares, la cuenta de **asignación atípica de recursos** de Goldknopf, argumenta que la misma atención estrecha-intensa puede atar las características sensoriales, sociales, ejecutivas y motoras del autismo — mientras advierte que es «probablemente un factor en personas autistas con fuertes síntomas sensoriales», no la causa única [4].

Como el monotropismo es una teoría de *cómo se gastan los recursos*, plausiblemente se extiende a muchos dominios. El cuadro honesto, sin embargo, se divide en tres niveles:

- **Nivel 1 — Enlaces directos, empíricamente apoyados.** El solapamiento autismo-TDAH («AuDHD») es el más fuerte: el MQ

muestra que la atención monotrópica está elevada en *ambas* condiciones, reencuadrando la «escisión monotrópica» (túneles competidores o inestables) como un fenotipo atencional real, medible [2][3][5]. Los solapamientos a nivel de mecanismo — la **interocepción** atípica y la **disfunción ejecutiva** — están bien evidenciados y ayudan a explicar problemas posteriores con alimentación, desorden y evitación [6][7][8].

- **Nivel 2 — Comorbilidad indirecta, de mecanismo compartido.** El autismo se solapa notablemente con la **anorexia/alimentación restrictiva** y el **TOC**. En cada caso la comorbilidad es real y replicada, pero el puente *mejor evidenciado* es un mecanismo compartido (interocepción; procesamiento ego-sintónico vs ego-distónico) en lugar del monotropismo específicamente [6][9][10].
- **Nivel 3 — Extrapolación plausible o constructos discutidos.** Algunos enlaces del encuadre popular — los «montoncitos del destino» (doom piles) como un fallo monotrópico de permanencia del objeto, la agorafobia como resultado monotrópico primario, la **PDA** como perfil distinto — descansan en evidencia más débil o discutida y deberían tratarse como hipótesis, no hechos establecidos [11][12][13].

A lo largo, un tema recurrente: muchos comportamientos que parecen «trastornos» separados se leen mejor como **el coste cognitivo de un sistema de atención estrecho colisionando con un mundo politrópico** — pero solo algunas de esas lecturas se han probado directamente.

1. Fundamentos: qué es el monotropismo, y qué tan sólido es

El monotropismo propone que las mentes difieren en cómo distribuyen los recursos atencionales. Una mente **politrópica** mantiene muchos canales de interés activos a la vez (amplia, superficial, cambio fácil); una mente **monotrópica** canaliza recursos a pocos «túneles de atención» intensamente activados (estrecho, profundo, difícil de cambiar) [1][3]. Los creadores — Dinah Murray, Wenn Lawson y Mike Lesser — presentaron primero la idea en las conferencias Durham sobre autismo desde 1992 y la formalizaron en 2005, argumentando que explica los

rasgos autistas (intereses especiales, necesidad de igualdad, malestar en las transiciones, foco en el detalle) mejor que los modelos solo deficitarios [1][14].

Su estatus científico ha cambiado en los últimos años:

- Es **empíricamente medible**. El MQ (Garau et al., 2023) es un instrumento de autoinforme de 47 ítems probado en 1.110 participantes (756 autistas, 354 no autistas). Los participantes autistas y con TDAH puntuaron significativamente más alto que los controles [2][3].
- Tiene un **primo mecanístico revisado por pares**. El modelo de «asignación atípica de recursos» de Goldknopf (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operacionaliza la intuición: en el autismo, los recursos atencionales están **estrechados** (a menos/menos áreas, modalidades y etapas de procesamiento, a veces más intensamente) y/o **reducidos** en capacidad global — un marco que explícitamente ata lenguaje, cognición social, atipicalidad sensorial/atencional y diferencias ejecutivas/motoras [4].
- Se sitúa **junto a, no en lugar de**, otras teorías cognitivas (Teoría de la Mente; coherencia central débil / estilo centrado en el detalle (Happé & Frith, 2006); disfunción ejecutiva) [4][15].
- Sigue siendo un **modelo, no un biomarcador**. Goldknopf es explícito en que es un factor entre varios, «probablemente» saliente en personas autistas con fuertes síntomas sensoriales [4]. Murray y colegas enmarcan similarmente el monotropismo como una *lente* unificadora, no una etiología completa [1][14].

Implicación para el resto de este brief: el monotropismo es una idea organizadora creíble, cada vez más validada, pero su *alcance explicativo* en cada comorbilidad debe argumentarse caso por caso — no asumirse.

2. Nivel 1 — Enlaces directos: el cluster neurodesarrollo

2.1 AuDHD y la «escisión monotrópica» (*vínculo directo más fuerte*)

El autismo y el TDAH co-ocurren mucho más a menudo de lo que el azar predeciría: el TDAH está presente en aproximadamente el **30–80 %** de las personas autistas, y el autismo en aproximadamente el **20–50 %** de aquellos con TDAH [5]; una metanálisis sitúa las tasas de síntomas de

TEA en muestras TDAH alrededor del **21 %** [16]; un gran estudio Medicaid encontró que **27 %** de los adultos autistas sin discapacidad intelectual tenían un diagnóstico TDAH co-ocurrente — aproximadamente 10× la tasa general [17]. El solapamiento es sustancialmente genético (~50–72 %) [18].

El monotropismo ayuda a resolver un viejo enigma: si el autismo es «hiperfoco» y el TDAH es «inatención», ¿por qué co-ocurren? El MQ responde empíricamente — **las personas con TDAH, especialmente AuDHD, también son altamente monotrópicas** [2][3]. La hiperfocalización en el TDAH (Grotewiel et al., 2022) es conceptualmente casi idéntica al túnel monotrópico [19]. El encuadre de la «escisión monotrópica» por tanto reencadra AuDHD no como opuestos sino como **un sistema inestable de túneles de atención compitiendo o cambiando rápidamente**: el cerebro demanda foco monotrópico profundo pero no puede estabilizar el túnel, produciendo la oscilación AuDHD familiar entre compromiso intenso, burnout rápido y subestimulación crónica [19][20].

Advertencia: el mecanismo de los «múltiples túneles competidores» es *plausible y consistente con los datos del MQ* pero no probado aún directamente como dinámica; debería leerse como una hipótesis fuerte.

2.2 Burnout autista y ruptura del túnel

El burnout autista — agotamiento crónico, pérdida de habilidades y tolerancia reducida — está cada vez más vinculado al coste acumulativo del cambio constante de túnel, el enmascaramiento y las demandas excediendo la capacidad, con tiempo insuficiente de recuperación/flujo [20][21]. Este es un área donde el monotropismo es heurísticamente poderoso (cada transición forzada es una ruptura de túnel), aunque la literatura del burnout en sí misma está todavía madurando y la vía monotropismo→burnout es en gran parte clínica/en primera persona en lugar de establecida experimentalmente [20].

2.3 Evitación de la demanda y PDA (*constructo discutido*)

Una demanda — «prepárate», «haz este formulario» — puede experimentarse como una intrusión violenta en un estado de flujo. Esta es la cuenta monotrópica intuitiva de la **evitación de la demanda**. El constructo más específico **Pathological Demand Avoidance (PDA)**,

acuñado por Elizabeth Newson en los años 1980 y ahora a menudo reencuadrado como «Pervasive Drive for Autonomy», describe una necesidad de control y evitación de demandas ordinarias impulsada por la ansiedad [11][22].

Dos cosas deben separarse:

- **El comportamiento de evitación de la demanda es real y común** en el autismo, y la cuenta monotrópica de «ruptura del túnel» es una *historia mecanicista* razonable para el pánico y la resistencia que produce.
- **La PDA como perfil o subtipo distinto no está establecida.** La National Autistic Society del Reino Unido declara «ninguna investigación ha encontrado evidencia fuerte de [la PDA] como perfil distinto» [11]; el estudio fundacional de Newson ha sido criticado por **razonamiento circular y sobreinterpretación** (grupos definidos por los investigadores eran luego «estudiados») [12][13]; y las revisiones notan problemas persistentes con definición, validez del constructo y medición [23]. Una revisión de 2023 se titula punzantemente «*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*» [13].

Así que el encuadre del texto fuente es medio correcto: la *experiencia* (una demanda rompe el túnel) está bien descrita por el monotropismo; la *entidad diagnóstica* (PDA) es discutida y no debería presentarse como establecida.

3. Nivel 2 — Comorbilidad indirecta, de mecanismo compartido

3.1 Anorexia y alimentación restrictiva

El solapamiento autismo–anorexia es robusto y bidireccional: aproximadamente **20–30 %** de los pacientes con trastornos alimentarios muestran rasgos autistas clínicamente significativos, con las tasas más altas en la anorexia nerviosa y el ARFID [6][24]; a la inversa, los adultos autistas tienen tasas elevadas de trastornos alimentarios. Críticamente, los rasgos autistas se observan **antes** del inicio del TA, así que el solapamiento no es meramente un efecto de inanición [6].

El puente *mecanicista* mejor evidenciado es la **interocepción** — la percepción de señales corporales internas (latido, saciedad). Una interocepción atípica está implicada en la etiología *tanto* del autismo como de los trastornos alimentarios y «puede, al menos en parte, ser responsable» de su comorbilidad [6]. La misma atipicalidad interoceptiva subyace a la **alexitimia** (dificultad para identificar/verbalizar emociones), presente en ~50 % de las personas autistas y ella misma vinculada a la patología alimentaria [7][8].

Dónde encaja el monotropismo (y dónde no): es razonable decir que una persona monotrópica profundamente en un túnel puede *perderse* las señales de hambre — pero la afirmación específica del texto fuente de que «el monotropismo reduce la interocepción» sobrestata la cadena causal. La relación evidenciada es **autismo** → **interocepción/alexitimia atípicas** → **vulnerabilidad alimentaria**; el monotropismo es una característica paralela del autismo, no la *causa* demostrada de la diferencia interoceptiva [6][7]. El seguimiento de comida/calorías también puede convertirse en un túnel por derecho propio, pero esto es plausible-mecanismo más que probado.

3.2 TOC vs hiperfoco: una distinción genuina

El autismo y el TOC co-ocurren sustancialmente: ~17 % de las personas autistas cumplen criterios de TOC, frente a ~1–2 % en la población general [9]. A pesar de la similitud superficial (comportamiento repetitivo, rigidez), el **impulsor afectivo difiere** y esto está bien establecido clínicamente:

- Los intereses restringidos/repetitivos **autistas** son típicamente **ego-sintónicos** — agradables, autoconfortantes, impulsados por el interés, a menudo reguladores.
- Las compulsiones del **TOC** son **ego-distónicas** — no deseadas, impulsadas por la ansiedad, realizadas para neutralizar los resultados temidos [9][10].

La distinción del texto fuente es por tanto correcta y respaldada por la evidencia, y está confirmada directamente por los propios participantes autistas: en un estudio cualitativo reportaron que los comportamientos repetitivos son «parte de quiénes son», mientras que los síntomas del TOC «conflictuaban con cómo se ven a sí mismos» [10]. El mismo estudio enmarca acertadamente la co-ocurrencia como «*Autism is the arena and*

OCD is the lion» — los síntomas del TOC pueden «secuestrar» los intereses especiales autistas, inflando su intensidad y malestar [10]. El monotropismo añade contexto (un túnel puede ser *capturado* por el contenido del TOC) pero la diferenciación descansa en el eje ego-sintónico/distónico, no en el monotropismo per se.

3.3 Ansiedad y trastornos afectivos (el sustrato bajo la «agorafobia»)

La ansiedad está entre las comorbilidades del autismo más comunes (una revisión secundaria cita ≥ 1 comorbilidad psiquiátrica en ~86 % de las personas autistas) [25]. Dos puntos de mecanismo importan para el cluster conductual de abajo: (i) la **hiper-responsividad sensorial** y la ansiedad están vinculadas, y a través del *condicionamiento de contexto* producen **evitación conductual de lugares generalizados** (restaurantes, tiendas, fiestas) [26]; (ii) la frecuente co-ocurrencia de alexitimia/dificultad interoceptiva significa que los estados emocionales están a menudo pobremente etiquetados, alimentando ansiedad difusa [7].

4. Nivel 3 — Cluster conductual/funcional: desorden, acumulación, evitación, retirada social

4.1 Desorden, «montoncitos del destino», y disfunción ejecutiva

El *fenómeno* está bien apoyado: las personas autistas y con TDAH muestran altas tasas de desorganización y desorden, y la ruta mejor evidenciada es la **disfunción ejecutiva** — déficits en categorización, toma de decisiones, planificación y memoria de trabajo [8][27]. Los síntomas de acumulación están elevados tanto en el TDAH (con un «vínculo especial con la inatención» [8a]) como en el autismo [8]; en el autismo específicamente, el trabajo cualitativo muestra que la dificultad para descartar está vinculada a **apegos de interés y significado**, no meramente al valor del objeto [28].

Advertencia sobre el texto fuente: la afirmación específica de que el desorden persiste por un «**déficit de permanencia del objeto**» autista («fuera de la vista, fuera de la mente») **no está apoyada por evidencia revisada por pares** que pudiera localizar. La permanencia del objeto es típicamente *intacta o superior* en el autismo; la experiencia de «fuera de

la vista, fuera de la mente» se lee mejor como un efecto de **memoria de trabajo/asignación de la atención** (una mente tunelizada no se reorienta a los ítems almacenados) que un fallo de permanencia del objeto perceptual. El mecanismo evidenciado para el desorden sigue siendo **disfunción ejecutiva más apegos de interés**, que se solapa con la población monotrópica/AuDHD pero no es únicamente «monotrópico» [4][8][28].

4.2 Comportamiento del espectro de la acumulación

El trastorno de acumulación afecta a ~1,5–6 % de la población general pero está elevado en el autismo [29]. En adultos autistas, la dificultad tipo acumulación para descartar se reporta con frecuencia junto a **dificultades cognitivas (ejecutivas) y fuertes apegos de interés/significado** — los ítems son nodos en una red de ideas y utilidad futura, así que descartar se siente con pérdida [28]. Esto es consistente con un *estilo* monotrópico (procesamiento profundo de objetos) pero, de nuevo, el impulsor evidenciado es FE/apego, compartido a través de las condiciones neurodelrollo [8].

4.3 Agorafobia y delimitación del «espacio seguro» (*necesita corrección*)

El texto fuente enmarca el confinamiento en casa agorafóbico como un resultado monotrópico casi directo. Los datos son más matizados:

- La agorafobia *está* elevada en el autismo — ~23–25 % de los adultos autistas (sin discapacidad intelectual) frente a ~1,3 % en la población general — **pero es menos común que la fobia social o el TAG**, y el efecto se concentra en aquellos sin DI [25].
- El impulsor mejor evidenciado es la **hiper-responsividad sensorial + ansiedad social**, con la evitación condicionada al contexto de lugares abrumadores — i.e., el comportamiento de «espacio seguro» es real pero es **secundario a la ansiedad sensorial/social**, no un fenómeno monotrópico primario [25][26].

Así que: el monotropismo ayuda a explicar *por qué* el mundo exterior se siente disruptivo (impredecible, politrópico, rompetúneles), pero clasificar el confinamiento resultante como «agorafobia» específica del monotropismo sobrestata el vínculo. Es una evitación impulsada por la ansiedad sensorial que *se solapa* con la experiencia monotrópica.

4.4 Retirada social, info-dumping, y el problema de la doble empatía

La interacción social es genuinamente politrópica — exige el seguimiento simultáneo de caras, tono, jerarquía, timing y reglas no escritas — así que es desproporcionadamente costosa para un sistema monotrópico, un punto consistente con el modelo de recursos de Goldknopf [4]. La intuición del texto fuente es acertada.

Pero el marco más afilado, *empíricamente apoyado*, para la ruptura comunicativa resultante es el **problema de la doble empatía** (Milton, 2012; 2017): la dificultad es *bidireccional* y relacional — una «disyuntura en la reciprocidad entre dos actores sociales diferentemente dispuestos» — no un déficit unidireccional de empatía en la persona autista [30]. El trabajo empírico muestra ahora que los observadores no autistas *tanto detectan como demuestran* el problema de la doble empatía en interacciones mixtas [31]. El «info-dumping» encaja naturalmente: es comunicación que busca profundidad de un sistema monotrópico, que falla cuando la pareja no puede igualar la profundidad — un desajuste de estilos de procesamiento, no una falta de empatía [30][31].

Brecha a señalar: la literatura DEP todavía excluye en gran medida a niños autistas, personas no verbales y personas con discapacidad intelectual, así que la generalización es limitada [32].

5. La frontera: dónde llega demasiado lejos la cuenta monotrópica

Afirmación en el encuadre fuente/laico	Estado de la evidencia	Mejor encuadre
El monotropismo <i>causa</i> las características del autismo	Parcialmente apoyado (MQ; Goldknopf)	Un factor organizador validado entre varios; más fuerte en autismo con sensorial [1][4]
AuDHD = «escisión monotrópica» (túneles competidores)	Fuerte + directamente medible (MQ)	Un fenotipo atencional real; el mecanismo dinámico es de nivel hipótesis [2][3]

Afirmación en el encuadre fuente/laico	Estado de la evidencia	Mejor encuadre
La PDA es un perfil autista distinto	Discutido	La evitación de la demanda es real; la PDA-como-entidad carece de validez de constructo [11][12][13]
El monotropismo <i>reduce la interocepción</i> → anorexia	Indirecto	El puente es autismo→interocepción/alexitimia→vulnerabilidad TA; el monotropismo es paralelo, no la causa mostrada [6][7]
Desorden por un «déficit de permanencia del objeto»	Sin apoyo	Disfunción ejecutiva + apego de interés; ningún déficit perceptual de permanencia del objeto evidenciado [4][8][28]
Agorafobia como resultado monotrópico primario	Exagerado	Secundaria a la hiper-responsividad sensorial + ansiedad social; menos común que TAG/fobia social [25][26]
TOC vs «obsesiones» monotrópicas difieren en afecto	Bien apoyado	Ego-distónico (TOC) vs ego-sintónico (interés autista); el TOC puede «secuestrar» túneles [9][10]
El problema de la doble empatía explica la ruptura social	Apoyado (pero brechas)	Desajuste bidireccional; las muestras sesgan a adultos verbales sin DI [30][31][32]

6. Preguntas abiertas

- 1. Prueba dinámica del túnel.** El MQ es una medida de *rasgo*. ¿Es la «escisión monotrópica» (túneles competidores/inestables en AuDHD) observable en atención/EEG en tiempo real? Largamente no probado.
- 2. Flecha causal a la interocepción.** ¿Una distribución de recursos monotrópicos *produce* atipicalidad interoceptiva, o comparten una

- causa común aguas arriba? La evidencia actual no puede separarlas [6][7].
3. **Resolución de la PDA.** ¿Convergerá la investigación de evitación de la demanda en un constructo validado, medible, o seguirá siendo una categoría laica/clínica discutida? [11][13]
 4. **Mecanismo del desorden.** ¿Es «fuera de la vista, fuera de la mente» un efecto de memoria de trabajo/asignación (plausible) o algo más? Ningún estudio dedicado encontrado.
 5. **Generalizabilidad DEP.** ¿Cómo opera el problema de la doble empatía para personas autistas no verbales, niños y personas con discapacidad intelectual co-ocurrente? [32]
 6. **Burnout.** ¿Cuál es la contribución específica, comprobable, de la ruptura del túnel monotrópico al burnout autista frente al enmascaramiento, el trauma y la demanda crónica? [20]
-

Fuentes

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]
- Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (preprint). Comentario/resumen:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; espejo: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire>
- [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — resumen de los hallazgos del MQ (47 ítems; N=1.110; autistas + TDAH puntúan significativamente más alto): <https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — revisión de comorbilidad TDAH y autismo (TDAH en ~30–80 % de TEA; TEA en ~20–50 % de TDAH; cita Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019):
<https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating

disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsyt.2025.1573263) — ~50 % de las personas autistas tienen alexitimia, mediada por déficits interoceptivos. <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] el «vínculo especial con la inatención» es el propio subtítulo del artículo. Véase también Drake Institute sobre TDAH/disfunción ejecutiva: <https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — resumen de revisión sistemática: ~17 % de las personas autistas cumplen criterios de TOC frente a ~1–2 % población general; distinción ego-sintónico vs ego-distónico: <https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (cualitativo). PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance («ninguna investigación ha encontrado evidencia fuerte de [la PDA] como perfil distinto»): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] *Frontiers in Education* (2024). Methods of studying PDA — crítica del razonamiento circular de Newson (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020): <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (citado vía estudio comparativo *Frontiers* 2024):

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (citado vía Psych Scene Hub y Autistica): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27 % de los adultos autistas sin DI tenían TDAH co-ocurrente (~10× general): <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — resumen del solapamiento genético (~50–72 %): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-audhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD como túneles competidores; referencias Grotewiel et al. 2022 sobre hiperfocalización del TDAH): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — What is monotropism? (estados de flujo; referencias Heasman et al. 2024 "autistic flow theory"): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, 1980s; reencuadre "Pervasive Drive for Autonomy"): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (cita también Westwood, Mandy & Tchanturia 2017; Huke et al. 2013). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agorafobia en el autismo ~23–25 % (sin DI) frente a ~1,3 % general; menos común que fobia social/TAG (fuente secundaria, basada en Helles et al. 2020 y Lugnegård et al. 2012): <https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — condicionamiento de contexto y evitación. PMC2980623.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (función ejecutiva, toma de decisiones): <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (cualitativo). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887 ; Milton (2017) extensión. Resumen: <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia — Double empathy problem (brechas de investigación reconocidas: niños, no verbales, discapacidad intelectual): https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Nota sobre los niveles de evidencia: Nivel 1 = medición directa, replicada (MQ; tasas AuDHD); Nivel 2 = comorbilidad replicada con un mecanismo compartido evidenciado; Nivel 3 = extrapolación plausible, fuente única o constructo discutido. Véase §5.